



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

**JUZGADO DE EJECUCION PENAL DE 1A.
NOM**

Protocolo de Autos

Nº Resolución: 855

Año: 2025 Tomo: 17 Folio: 5037-5052

EXPEDIENTE SAC: xxx - A., E. A. - CPO. DE EJECUCION DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

PROTOCOLO DE AUTOS. NÚMERO: 855 DEL 05/09/2025

Córdoba, dos de septiembre de dos mil veinticinco.

Y VISTA:

Que en la presente causa caratulada “A., A. E. S/ EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD”, (Expediente SAC nº xxx), que se tramita por ante este Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación.

DE LA QUE RESULTA:

I) Que el interno A., E. A., leg. Nº xxx, fue condenado por la **Excma. Cámara en lo Criminal de Quinta Nom. de la ciudad de Córdoba**, mediante **Sentencia Nº 48 de fecha 20/10/1998** por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de encubrimiento, tenencia de arma y munición de guerra en concurso real (segundo hecho con anterioridad al 04/10/1996), coautor de robo calificado reiterado tres hechos (hecho tercero del 04/10/1996), coautor de robo calificado y autor de homicidio calificado en concurso real (cuarto hecho del 04/10/1996) y autor del delito de robo calificado (hecho quinto del 04/10/1996), todo en concurso real en los términos de los arts. 45, 277 inc. 3º, 189 tercer y quinto párrafo del CP, ley 20.249 y decretos reglamentarios 395/75 y 821/96; y 55 CP, 45, 166, inc. 2º y 55; 45, 166 inc. 2º, 80 inc. 7º y 55; y 166 inc. 2º y 55 C. Penal, imponiéndole la pena de **PRISIÓN PERPETUA, CON DECLARACIÓN DE**

REINCIDENCIA (art. 50 CP) con costas (arts. 550 y 551 CPP) (fs. 2/48).

II) Según oficio remitido por el Tribunal de condena al Juzgado de Ejecución Penal de 1ª nominación de la ciudad de Córdoba de fs. 144 surge que **A. fue detenido por los hechos por los que cumple condena el día 19-10-1996, sin recuperar su libertad desde entonces.**

III) Que surge de constancias de autos, que **el Juzgado de Ejecución Penal n° 2 de Cruz del Eje**, a cuya disposición se encontraba el interno A., resolvió con **fecha 16.06.2022**: ***“I. OTORGAR el beneficio de prisión domiciliaria al interno E. A. A. (Leg: xxx) (art. 32 ley nacional n° 24.660) a partir del día de la fecha, bajo el cuidado de Sra. A. I. F. DNI: xxx en calidad de tutora, con la obligación de residir en el domicilio sito en calle xxx, con la obligatoriedad de permanencia en el domicilio consignado bajo apercibimiento de inmediata revocación del beneficio (art. 34, Ley 24.660); II. CONFIAR la supervisión de la detención domiciliaria otorgada a E. A. A. al Departamento de Reinserción Social del Liberado de la Provincia. III. PROTOCOLÍCESE, notifíquese y oficiése...”*** Sin embargo, cabe aclarar que el condenado, al haber fijado domicilio en la ciudad de Córdoba, se encuentra actualmente a disposición de este Juzgado.

IV) Que fue detenido nuevamente **con fecha 27.07.2022** y alojado en el Complejo Carcelario n° 1 de Bouwer, a disposición conjunta con la **Fiscalía de Instrucción de Narcotráfico de Cruz del Eje**, por la presunta comisión de hechos de comercialización de estupefacientes, **algunos cometidos en el domicilio donde cumplía la prisión domiciliaria** y otros mientras estaba alojado en el Complejo Carcelario n° 2, de la ciudad de Cruz del Eje, cuestión que se confirmaría en la Sentencia condenatoria que se describe más abajo.

Que en consecuencia, este Juzgado fue informado por dicha Fiscalía que el día **22/08/2022** **se le dictó Prisión Preventiva** al incoado A., quien estuvo alojado en el Módulo MD1 de Bouwer, hasta el día 12.09.2022, fecha en que se le concedió nuevamente la Prisión Domiciliaria con dispositivo electrónico.

Así, mediante **Auto n° 277 de fecha 12.09.2022**, la **Fiscalía de Instrucción Móvil del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico**, le otorgó a **A. el beneficio de la prisión domiciliaria**, por la causal del inciso a) del art. 32 de la ley 24.660, y resolvió: *“En la ciudad de Cruz del Eje, a los doce días del mes de septiembre de dos mil veintidós... el Sr. Fiscal de Instrucción Móvil del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico y Secretario autorizante, ha dispuesto otorgarle a A. E. A., D.N.I. N° xxx, el beneficio de la prisión domiciliaria en el domicilio sito en calle xxx de la localidad de Córdoba, de la Pcia de Córdoba, bajo la supervisión de un sobrino político F. A. G. DNI xxx (con mismo domicilio), quien se compromete a hacer cumplir las obligaciones por las cuales se otorga la medida. En este estado el Sr. Fiscal de Instrucción le informa al imputado A. E. A., las condiciones impuestas en la resolución del día de la fecha que dispone la medida, a saber: 1) La permanencia absoluta en el domicilio en calle xxx de la localidad de Córdoba, de la Pcia de Córdoba, bajo responsabilidad y custodia de F. A. G. DNI xxx, bajo apercibimiento de inmediata revocación (artículo 34, ley 24.660) 2) Permanecer a disposición del órgano judicial y concurrir a todas las citaciones que se formulen; 3) No obstaculizar la acción de la justicia en el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley; (vr.gr No contactarse con personas implicadas en los hechos que se investigan en la causa ni directa ni indirectamente, ni personalmente ni a través de cualquier medio) (art. 268 del C.P.P.). 4) Asimismo, deberá el imputado A. respetar la siguiente regla u obligación: No cometer nuevos delitos, en especial en infracción a la ley 23.737; todo ello bajo apercibimiento de revocársele el beneficio obtenido. II.- El presente beneficio deberá hacerse efectivo una vez que la autoridad penitenciaria implemente la colocación del dispositivo electrónico de control...”*.

(lo resaltado me pertenece) (v. oficio adjunto con fecha 19.09.2022).-

V) Que con fecha 15.08.2024 la Excma. Cámara del Crimen de Cruz del Eje, resolvió

mediante sentencia n° 127 : “...II) Declarar a E. A. A., filiado supra, autor penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes –primer hecho- y coautor del delito de comercialización de estupefacientes doblemente agravada por ser cometida con la intervención organizada de tres o más personas y en el interior de un lugar de detención -segundo hecho, todo en concurso real y aplicarle la pena de seis años y seis meses de prisión, multa de 67,5 unidades fijas, decomiso de los elementos secuestrados y detallados en los considerandos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, declaración de reincidencia y costas (Arts. 5, 9, 12, 23, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 55 y 77 todos del C.P.; 14 primer párrafo, 5 letra “c”, 11 letras “c” y “e” de la Ley N° 23.737; 1 de la Ley Pcial. 10.067; y arts. 408, 409, 412, 415, 550 y 551 del C.P.P.). **III) Unificar** el remanente de la pena impuesta por la Cámara en lo Criminal y Correccional de 5ta. Nominación de la ciudad de Córdoba mediante Sentencia N° 48 de fecha 20.10.1998 y la recaída a través de la presente resolución en la **única de prisión perpetua, multa de 67,5 UF, decomiso de los elementos secuestrados y detallados en los considerandos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, declaración de reincidencia y costas** (Art. 58 del C.P.)...”. “(...)” VI) **Ordenar la realización de una pericia médica a los fines de determinar el estado de salud actual del condenado A. y la viabilidad de que el encierro sea efectivo, habiendo evidenciado que la modalidad domiciliaria fue utilizada para profundizar su actividad delictiva relacionada con el flagelo de la droga, con el consiguiente enorme perjuicio a la sociedad y a la salud pública que esto trae aparejado.**”.

VI) 1– Que atento a lo ordenado por el Tribunal de condena, mediante decreto de fecha 19.08.2024, este Juzgado dispuso: “Córdoba, diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro. Atento a que en el punto VI) de la sentencia de condena dictada por la Cámara en lo Criminal y correccional de la ciudad de Cruz del Eje de fecha 15.08.2024 se dispuso: “...VI) Ordenar la realización de una pericia médica a los fines de determinar el estado de salud actual del condenado A. y la viabilidad de que el encierro sea efectivo,

*habiendo evidenciado que la modalidad domiciliaria fue utilizada para profundizar su actividad delictiva relacionada con el flagelo de la droga, con el consiguiente enorme perjuicio a la sociedad y a la salud pública que esto trae aparejado...” y de las constancias de autos; **SE RESUELVE:I.** Dispóngase que la realización de la pericia médica ordenada, deberá ser realizada por parte de **dos peritos médicos oficiales** del Equipo Técnico de Medicina Forense, sobre el **interno A., E. A., DNI N° xxx, leg. Penitenciario n° xxx**, a fin de determinar lo dispuesto en el punto VI) de la sentencia de condena, a lo que **se deberán adicionar los siguientes puntos:** 1º) Informar las patologías que el interno de marras padece; 2) Indique si la permanencia en un establecimiento penitenciario le impediría recuperarse o tratar adecuadamente sus patologías y en su caso si no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario, 3) Si las patologías son incurables en período terminal, 4) Si, por las patologías que padece, el interno puede considerarse un discapacitado y en su caso, si la privación de la libertad en el establecimiento carcelario resultaría inadecuada, por esa condición, implicando un trato indigno, inhumano o cruel y 5) Toda otra cuestión que pueda resultar de utilidad desde la perspectiva de la procedencia o no de la prisión domiciliaria. Hágase saber a las partes que les asiste el derecho de designar perito de control en los términos del artículo 237 del Código Procesal Penal de la Provincia. Asimismo, infórmese a las mismas, que el/la perito de control que fuera designada, tendrá un plazo para presentar las consideraciones que estime necesarias, de 72 horas a contar desde la presentación del informe pericial por parte del perito oficial, a los fines de poder continuar con el trámite del incidente del beneficio liberatorio petitionado. Notifíquese....” Decreto que fuera notificado mediante e-cédula a la defensa el mismo día de su dictado.*

2– Así, con motivo del decreto referido ut supra, la defensa presentó escrito de **fecha 20.08.2024**, en el que manifestó: “Gustavo Taranto, en el carácter de defensor del condenado A., E. A., en estos autos: A., E. A. - CPO. DE

EJECUCION DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, SAC xxx, ante S.S., respetuosamente comparezco y digo: Atento el decreto que fuera notificado a la defensa en el cual se dispone la realización de una pericia médica, informa y solicita: **Que ni su defendido ni la familia cuentan con recursos para contratar un perito de control, por lo que desisten de ofrecerlo.** Sin perjuicio de lo señalado y a los fines de ilustrar la tarea profesional a realizarse, garantizando un exhaustivo conocimiento de los antecedentes médicos de A., por parte de los médicos, solicita: Se requiera al Hospital Córdoba de esta ciudad de Córdoba, copia de la historia clínica del condenado con copia de los estudios realizados. Sea entrevistada por los peritos, la Dra. Marcela Giacometti, cardióloga del Hospital Córdoba, profesional que atendió a A. en reiteradas oportunidades y le ha dado a A. un mal pronóstico de su salud. Se le entregue a los peritos las conclusiones de la pericia realizada con anterioridad por orden del Juez de ejecución de Cruz del Eje, a fin de evaluar si desde ese momento ha variado la salud de A.. Se requiera al servicio médico del Hospital modular ubicado dentro de la cárcel de Bouwer estuvo internado A., los antecedentes que motivaron esa internación. Se requiera antecedentes e historia clínica en el Hospital San Roque de esta ciudad donde también se registran antecedentes de internación por iguales patologías. Finalmente se solicite la historia clínica de A. que existente en el Hospital Regional Aurelio Crespo de la ciudad de Cruz del Eje donde también se registran antecedentes de internación por iguales patologías. Los antecedentes solicitados servirán a los profesionales a los fines indicados en el decreto para un mejor conocimiento del total de antecedentes médicos de su defendido. PETITUM. Tenga presente lo manifestado. Haga lugar solicitando los antecedentes médicos a A. para ser provistos a los peritos en el acto médico – procesal.”

3– Seguidamente, con fecha 20.08.2024, este juzgado en respuesta a su escrito dispuso: “Córdoba, veinte de agosto de dos mil veinticuatro. Atento al escrito presentado por la defensa técnica del penado A., E. A.; **SE RESUELVE: I.** Téngase

presente la renuncia a ofrecer perito de control a los fines de la realización de la pericia médica ordenada. II. A lo demás solicitado, téngase presente para su oportunidad, si correspondiera.”

4– Así las cosas, luego de serle remitidos los informes del servicio penitenciario, la historia clínica de A. obrante en el establecimiento penitenciario y el auto de concesión de prisión domiciliaria por el Juzgado de ejecución penal de Cruz del eje, y de ser notificado al abogado defensor el decreto de fecha 03.09.2024, mediante el cual se fijó la **pericia médica para el día 20.09.24, la misma fue realizada** por el Servicio de Medicina Forense ese mismo día, conforme obra adjunta en operación de fecha 04.10.2024.

En dicho acto pericial, los **peritos médicos forenses** dan cuenta: “...*En cumplimiento de lo solicitado por Ud. en Oficio de fecha 30/08/2024, con relación a los autos caratulados “A. E. A. - EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD” (SAC n.º xxx) que se tramitan por ante este Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación, venimos por el presente, a responder lo solicitado con relación al interno E. A. A.. ANTECEDENTES: Se encuentra cursando prisión domiciliaria. Tiene tobillera. Sin documental médica actualizada. El Sr. E. A. A. de 64 años, refiere como antecedente personal patológico: ser hipertenso de larga evolución y de difícil control, diagnosticado en el Hospital San Roque viejo en el año 1996. Refiere último control con médico cardiólogo de cabecera de Hospital Córdoba, en junio de este año, donde además se le realizaron varios estudios (ECG, Eco Doppler, entre otros), pero que no tiene turno/no ha conseguido turno para regresar a la consulta con los ellos y tener una respuesta por parte de su médico. Refiere presentar insomnio y que para ello, toma una pastilla que le da su hermana (clonazepam 2mg o alpax 2mg). Antecedentes tóxicos: no refiere. Medicación habitual: amlodipina; recorval 3D; esplerona; carvedilol, recorval 320; furosemda. ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO, Ingresa a consultorio por sus propios medios, sin acompañantes y sin dificultad en la marcha. Se presenta colaborador a la*

anamnesis y el examen físico. Trae registros de control de TA (todos elevados). **MEDICINA FORENSE | 2** Al momento del examen se encuentra estable y asintomático, con tensión arterial registradas de 207/132 y 210/130 mmHg, una frecuencia cardíaca de 85 lpm y ruidos cardíacos: R1 y R2 normo fonéticos. Leve edema en miembros inferiores. Presenta buena mecánica respiratoria, sin uso de músculos accesorios, una frecuencia respiratoria de 16 ciclos por minuto, con buena entrada de aire en ambos campos pulmonares y sin ruidos agregados, sin tos, moco o expectoración, tampoco presenta agitación al colaborar con el examen respiratorio. Saturación aire ambiente del 98%. Examen neurológico: lucido, sin signos de foco motor ni meningismo al momento del examen. Refiere encontrarse asintomático al momento de la presente valoración. Manifiesta su preocupación por no poder conciliar el sueño. Situación que reitera en varias oportunidades durante la entrevista. Se encuentra verborrágico, impresiona angustiado por dicha situación. **ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO,** Ingres a consultorio por sus propios medios, sin acompañantes y sin dificultad en la marcha. Se presenta colaborador a la anamnesis y el examen físico. Trae registros de control de TA (todos elevados). **MEDICINA FORENSE | 2** Al momento del examen se encuentra estable y asintomático, con tensión arterial registradas de 207/132 y 210/130 mmHg, una frecuencia cardíaca de 85 lpm y ruidos cardíacos: R1 y R2 normo fonéticos. Leve edema en miembros inferiores. Presenta buena mecánica respiratoria, sin uso de músculos accesorios, una frecuencia respiratoria de 16 ciclos por minuto, con buena entrada de aire en ambos campos pulmonares y sin ruidos agregados, sin tos, moco o expectoración, tampoco presenta agitación al colaborar con el examen respiratorio. Saturación aire ambiente del 98%. Examen neurológico: lucido, sin signos de foco motor ni meningismo al momento del examen. Refiere encontrarse asintomático al momento de la presente valoración. Manifiesta su preocupación por no poder conciliar el sueño. Situación que reitera en varias oportunidades durante la entrevista. Se encuentra verborrágico, impresiona angustiado por dicha situación. **OPINION MEDICO LEGAL:** Por lo

anteriormente expuesto, es posible concluir que E. A. A., de 64 años, tiene los antecedentes médicos ut supra referidos. Al momento de la anamnesis y el examen físico realizados, se encuentra HTA, asintomático y hemodinámicamente estable. Al momento de la presente valoración, se encuentra transitando prisión domiciliaria, situación que no le impide realizar el tratamiento médico así como asistir a los controles médicos. Esto último se encuentra dificultado últimamente, porque según refiere el interno, no consigue turno. Sin embargo, toma la medicación con regularidad y realiza los estudios complementarios según se le han indicado. Salvo complicaciones, la patología que presenta es de carácter crónico, puede cursar con periodos de estabilidad y también puede reagudizarse e incluso requerir internación en nosocomios, es de destacar que estas complicaciones o reagudizaciones podrían manifestarse ya sea estando privado de la libertad, o en su domicilio. Solicitamos: arbitrar los medios para realizar una consulta médica ambulatoria prontamente con Médico especialista en Cardiología (su médico de cabecera en la Institución Pública en que fue asistido en junio pasado) para control y valoración de su estado de salud actual, así como la realización de todos los estudios complementarios, controles e indicaciones médicas que sean indicados eventualmente por el facultativo en cuestión. Solicitamos, además, se realice una valoración por parte de Médico psiquiatra (sea Perito oficial o médico de Hospital Público) dado lo relatado por el interno. En el caso de presentar interurrencias / descompensaciones agudas, deberá ser asistido por personal médico acorde a la situación presente...”. A mérito de lo solicitado por el defensor y de lo expresado con fecha 20.09.2024 por los médicos forenses, **obra con fecha 04.10.2024, entrevista a la Dra. GIACOMETTI, médica cardióloga de cabecera del condenado A.,** de la que se desprende: “DECLARACIONTESTIMONIAL DE S. M. G.: En la ciudad de Córdoba, a cuatro días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro, siendo día y hora de audiencia, comparece ante S.S. y Prosecretaria letrada autorizante una persona que debe prestar declaración testimonial en las presentes actuaciones “A., E. A. –

ejecución de pena privativa de libertad” (sac n° xxx). Enterada del objeto del acto y de las penalidades del falso testimonio, prestó juramento en legal forma. Acto seguido S.S. le interroga por su nombre, apellido y demás condiciones, respondiendo llamarse S. M. G., D.N.I .xxx, ser de nacionalidad argentina, de 52 años de edad, con instrucción universitaria, título médico especialista en cardiología, trabajaba en Servicio de Cardiología del Hospital Córdoba, hasta 31 de agosto de 2024, preguntada por las demás generales de la Ley, que previamente le fueron explicadas, dijo: que no le comprenden. Interrogada por su conocimiento de la condición médica del Sr. A., A. E., dni n° xxx se le hace saber el estado procesal en el que se encuentra la causa “A., A. E. – CPO. EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD” SAC N° xxx, del cual es informada y de que el mismo, se encuentra en prisión domiciliaria, dijo: que, siendo atendido desde 2022 hasta aproximadamente a mitad del corriente año, por la declarante, debido a padecer la patología de hipertensión arterial esencial, siendo atendido por consultorio externo en Cardiología en Hospital Córdoba, donde pudo constatar que su condición de enfermedad de hipertensión es de difícil manejo, requiriendo tratamiento con más de tres fármacos en sus dosis máximas, por lo que se diagnostica Hipertensión resistente, o pseudoresistente, es decir que el paciente mantiene tensiones arteriales fuera de la meta a pesar del tratamiento. En múltiples consultas, se evaluó verbalmente la adherencia al tratamiento, es decir la toma de la medicación antihipertensiva indicada en forma correcta refiriendo el paciente ser adherente, por esto se intentó corroborar la eficacia terapéutica con mapeo de la presión arterial en el domicilio por 24 hs(M.A.P.A.), obteniéndose un estudio no satisfactorio por la poca cantidad de mediciones registradas, solo 20 % aproximadamente de mediciones útiles. También se derivó a un especialista en hipertensión, para controlar la terapia, la cual siempre requería ajustes, aunque en el último tiempo, había empezado a dar resultado el siguiente tratamiento o esquema terapéutico, que recuerda: eplerenona 50 mg/día, valsartán 320 mg/día, amlodipina

10 mg/día, hidroclorotiazida 25 mg/día, furosemida 40 mg cuatro veces a la semana, carvedilol 25 mg/día, más dieta hiposódica y abstención de tóxicos. **Todo esto, podría indicar la posibilidad de que la no toma de medicación indicada sea, una de las causas más probables de la falla en la respuesta al tratamiento.** A la pregunta sobre la gravedad de la patología que padece A., indica la declarante que tiene cambios a nivel cardíaco, que aún no repercuten fuertemente en su salud como único daño orgánico por esta patología. También se hicieron estudios iniciales para descartar otras causas de hipertensión arterial, los cuales fueron negativos. Preguntada por si entiende que si el paciente A. quisiese, podría manipular su enfermedad, responde que sí es posible, ya que la hipertensión es una patología que la puede controlar bastante el paciente una vez que aprende a conocer el efecto de la toma de los remedios y el efecto de no hacerlo, lo mismo el paciente aprende a saber los efectos de no cumplir con las pautas dietarias y de uso tóxicos, los cuales están contraindicados en pacientes hipertensos, es decir, si no toma la medicación como está indicada y no cumple con las pautas dietarias y de no consumo de tóxicos, la presión sube. Es una posibilidad en este paciente, ya que nunca tuvo certeza de que el paciente cumpliera las indicaciones correctamente, ya que a veces no recuerda el tratamiento que le indicó. Conozco que A. consultó actualmente (fines de agosto) a la guardia por control de dolores de pecho y al ser preguntado sobre qué medicación tomaba, no supo responder tampoco con exactitud. A la pregunta: ¿Cómo usted evalúa si toma o no la medicación, qué solución podría ser factible? Responde que podría ser factible, un control de 24-48 hs. de supervisión constante respecto de la ingesta de los medicamentos y de su efecto a través de un M.A.P.A. que sea técnicamente efectivo o por medio de registros de la tensión arterial seriados, reiteradas veces en el día, siendo que esta enfermedad y su tratamiento se basa en registros de los valores de la tensión arterial. A la pregunta: ¿Habría alguna imposibilidad económica de acceder a la medicación por parte del Sr. A.? A lo que responde: Tengo certeza de que la provisión de su tratamiento estaba asegurado a través de la farmacia

gratuita del hospital o en su defecto muestras médicas que se le entregaban directamente al paciente al menos en el tiempo que estuvo bajo mi atención. Que es cuanto tiene que declarar... ”.

VII) 1– Que con fecha **06.08.25** se dispuso: “Córdoba, seis de agosto de dos mil veinticinco. Atento a las conclusiones de la pericia médica de fecha 20.09.2024 realizada sobre el penado **A., E. A., DNI N° xxx, leg. Penitenciario n° xxx**, quien se encuentra en prisión domiciliaria y advirtiendo que en la misma no se han determinado los puntos solicitado en forma completa, resultando ambiguas y escuetas sus conclusiones, siendo a su vez que pueden advertirse discrepancias entre ésta y las conclusiones de la pericia médica oportunamente realizada y por la cual el Juzgado de ejecución penal de Cruz del eje le concediera al penado la prisión domiciliaria, sumado ello a la testimonial receptada por este juzgado a la médica cardióloga de cabecera Dra. Giacometti y habiendo transcurrido un tiempo prudencial a la fecha, **SE RESUELVE:** Oficiar al **Equipo Técnico de Medicina Forense**, a fin que arbitre los medios necesarios para realizar un informe aclaratorio y completar las conclusiones periciales de fecha 20.09.2024 en relación al penado **A., E. A., DNI N° xxx, leg. Penitenciario n° xxx**, **debiéndose** responder a la totalidad de los puntos solicitados, con especial énfasis en la posibilidad o no de permanencia del interno en un establecimiento penitenciario para el cumplimiento de la condena. **Para mayor resguardo se transcribe lo solicitado oportunamente en relación a dicho informe, el que deberá determinar categóricamente** si la permanencia en un establecimiento penitenciario del penado le impediría recuperarse o tratar adecuadamente sus patologías o si la privación de la libertad en el establecimiento carcelario resultaría inadecuada, por dicha condición médica oportunamente establecida, implicando ello un trato indigno, inhumano, cruel o degradante. Se adjunta para la confección del mismo la declaración testimonial de la médica cardiología de cabecera referida previamente, a sus efectos.”.

2– Que fueron remitidas al Servicio de Medicina forense, previo a la realización del informe aclaratorio, las **historias clínicas obrantes en el Hospital Córdoba, Hospital Tránsito Cáceres de Allende y Hospital Oncológico Provincial**, nosocomios donde le habían brindado o le estaban brindando asistencia médica. Sumado a ello, se acompañó entrevista realizada a la **Dra. Marcela Giacometti, cardióloga del Hospital Córdoba**, ello atento a lo solicitado por el defensor en el escrito de fecha 20.08.2024 al manifestar “...*profesional que atendió a A. en reiteradas oportunidades y le ha dado a A. un mal pronóstico de su salud...*”. Así las cosas, con **fecha 11.08.2025** siendo citado a este juzgado a los fines de celebrar audiencia, junto a su abogado defensor, en el mismo acto se le notifica de la citación a los consultorios de medicina forense para el día 13.08.2025, (en la oficina, y mediante e-cédula enviada el mismo día) quien debía hacerse presente a los fines del informe aclaratorio. 3– Que fue incorporado el **informe aclaratorio** con fecha **13.08.2025**, elaborado por los Dres. Alicia Muscarello, Verónica Hancevic y Guillermo Tillard del Equipo de Medicina Forense y del mismo surge en relación al condenado A. que “...*En cumplimiento con lo ordenado en los autos caratulados “A. E. A. - EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD” (SAC n.º xxx), que se tramitan por ante este Juzgado, se ha dispuesto librar el presente a fin de comunicar que en el día de la fecha, se procedió a realizare l informe solicitado sobre el penado A., E. A., quien se encuentra en prisión domiciliaria, a fin de establecer la posibilidad o no de permanencia del interno en un establecimiento penitenciario para el cumplimiento de la condena y determinar categóricamente si la permanencia en un establecimiento penitenciario del penado le impediría recuperarse o tratar adecuadamente sus patologías o si la privación de la libertad en el establecimiento carcelario resultaría inadecuada, por dicha condición medica oportunamente establecida, implicando ello un trato indigno, inhumano, cruel o degradante.* **ANTECEDENTES:** Edad: 65 años. Antecedentes patológicos:

espondilolistesis L4/L5. HTA de larga evolución, diagnosticada en 1996, de difícil manejo y con múltiples consultas por crisis hipertensivas. Síndrome coronario (no se objetiva lesiones coronarias en la documental aportada). Antecedentes quirúrgicos: cirugía en miembro inferior izquierdo por herida de arma de fuego. Cirugía por estrechamiento del canal medular. Antecedentes tóxicos: no refiere. Antecedentes alérgicos: no refiere. Medicación habitual: amlodipina 10mg c/12, hidroclorotiazida 12,5mg c/24, furosemida 40mg c/24, carvedilol 12,5mg c/12, valsartan 320 mg c/24hs, espiroonona 25 mg/d. Levomepromacina y Escitalopram. Historia clínica Hospital Córdoba con fecha 09/08/25 Paciente de 65 años de edad, con antecedentes de HTA de difícil control y 2 IM (2022), consulta en guardia por presentar valores de TA 220/120 acompañado de cefalea frontal opresiva de 1 semana de evolución que cede levemente con paracetamol y náuseas. Refiere dolor punzante precordial localizado, no irradiado que duró 5 minutos y cedió espontáneamente el día 08/08. Niega náuseas, vómitos, disnea y otra sintomatología. CSV: T° 36.4 FC 91 FR 17 TA 220/120 SatO2 96% Ex Neurológico: lúcido, pupilas reactivas isocóricas, lenguaje fluente y coherente moviliza 4 miembros, sin signos de foco motor o meníngeo. Ex CV: R1-R2 hipofonéticos, sin soplos, no presenta edemas en MMII o IY. Ex Respiratorio: buena mecánica ventilatoria, MV conservado en ambos campos pulmonares, sin ruidos sobreagregados. Ex Abdomen: RHA (+), abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación. Ex GU: PPRB (-), PRU (-). Métodos complementarios: - ECG: ritmo sinusal, FC 75, eje desviado a la izquierda, P 0.08, PQ 0.08, QRS 0.08, ST isoelectrico, QT0.36, tT0.12. Onda q en DI DII y aVF. Sin signos de isquemia aguda. - Laboratorio: GB 9.74 (NS63%) - HTO 48.2 - HB 16.3 - PLAQ 211000 - APP 87 - KPTT 31.1 - GLUC 98 - UR 46 - CR 1.42 - PCR 0.06 - GOT 28 - GPT 19 - GGT 14 - BT 0.56 - BD 0.56 - BD 0.26 - BI 0.30 - FAL 76 - GV ph 7.39 / bicarbonato 31.3 / Na 142 - K 4 - Cl 99 - ácido láctico 1.58. - RX de tórax: Impresión ICT aumentada, botón aórtico prominente, senos costofrénicos libres, no se observa infiltrados pulmonares. Conducta: Se indica amlodipina 10 mg + losartan 50 mg + dipirona y metoclopramida en 100 ml de solución

fisiologica. Evolucionó con mejoría de la clínica , TA 170/80. Se indica aumentar la hidroclorotiazida a 12,5 c/12 hs a la medicación habitual. Se solicita ecocardiograma, ecografía renovesicoprostatica y control por consultorio externos de Cardiología y Clínica Médica. Se explican signos de alarma. **Estudios complementarios:** Eco doppler de vasos del cuello con fecha junio 2023:Ateromatosis leve.No se verifican obstrucciones hemodinamicamente significativas. Señales doppler conservadas. Engrosamiento miointimal de paredes de ambas carótidas comunes.Estenosis del 17 % de car. común izq.Eco doppler color vasos renales junio 2023:No se observan trombos. Sin obstrucciones hemodinamicamente significativas.Aorta abdominal sin dilataciones sin ateromatosisLechos proximales y distales hiliares de ambas renales sin alteraciones con flujos conservados y simetricosArterias arcuatas intraparenquimatosas con flujos normalesEcocardiograma doppler (ETT) con fecha mayo 2024:Cavidades cardíacas de tamaño normal.VI de tamaño normal, hipertrófico, con cinesia y función sistólica conservada (Fey 66%).Aortoesclerosis. Válvulas estructuralmente normales. Cavidades derechas de tamaño normal con función sistólica de VD conservada.Disfunción diastólica de VI grado I (patrón de relajación prolongada).Ecocardiograma doppler (ETT) con fecha agosto 2024Dilatación leve de AI con área 2D de 22.3 cm².VI de tamaño normal, hipertrófico, con cinesia y función sistólica conservada (Fey 66%).Aortoesclerosis.Válvulas estructuralmente normales.Cavidades derechas de tamaño normal con función sistólica de VD conservada. IAO leve.IM leve. Disfunción diastólica de VI grado I (patrón de relajación prolongada).**EXAMEN FISICO** Se encuentra cursando prisión domiciliaria. Tiene tobillera. Ingresa a consultorio por sus propios medios. Al momento del examen se encuentra con hipertensión arterial severa pero asintomático, TA brazo derecho 210/130mmHg, brazo izquierdo 200/130- FC 94 lpm- SatO₂ 97%. R1 y R2 NF, no edema ni ingurgitación yugular, sin signos de sobrecarga hídrica. Buena mecánica respiratoria, sin ruidos agregados,Examen neurológico: lucido, sin signos de foco motor ni meningismo al momento del examen.No refiere sintomatología alguna al

momento del presente examen.**OPINION MEDICO LEGAL:** Luego de un minucioso análisis de toda la documental remitida y examen físico del Sr. **E. A. A.**, cabe establecer que padece los antecedentes citados y en relación a su patología de HTA, la misma es de carácter crónico para la cual se encuentra medicado y con controles seriados por servicio de Cardiología del Hospital Córdoba. Si bien la misma, consta ser de difícil manejo, no hay evidencia en la documental remitida de lesión de órgano blanco secundaria a la misma, como ser ACV, infarto de miocardio, daño renal, compromiso vascular aórtico u oftalmológico. Cabe señalar que la principal causa de la falla de respuesta terapéutica al tratamiento anti hipertensivo es la falta de adherencia al mismo por parte del paciente. En este caso, no es posible establecer si el Sr. **A.** cumple estrictamente o no con el tratamiento indicado. Así mismo, cabe destacar que la patología que padece puede presentar complicaciones independientemente del lugar de alojamiento, por lo que su permanencia en un establecimiento penitenciario no le impediría recuperarse o tratar adecuadamente su patología ni la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le resultaría inadecuada, por dicha condición médica, ni implicaría un trato indigno, inhumano, cruel o degradante. Por todo lo antes citado, **E. A. A.** puede permanecer alojado en un establecimiento penitenciario. Se sugiere que la toma de su medicación antihipertensiva se realice en el servicio Médico Penitenciario para supervisar el cumplimiento del mismo y que continúe bajo seguimiento estricto del Servicio de Cardiología tratante del Hospital Córdoba y se le practiquen los estudios solicitados por dicho servicio. Se indica además que sea evaluado por Guardia Central del Hospital Córdoba debido a la hipertensión arterial constatada durante el presente examen...”.

VIII) 1– En razón de todo ello, con fecha **19.08.2025**, este Juzgado dispuso **ordenar la detención del interno A. y el allanamiento** de su domicilio al solo efecto de la detención, lo cual se cumplimentó, quedando alojado a disposición exclusiva de este juzgado en el Complejo Carcelario n° 1.-

2- Así, se resolvió: “Córdoba, diecinueve de agosto de dos mil veinticinco.-Atento a que el condenado A., E. A., DNI N° xxx, leg. Penitenciario n°xxx, quien se encuentra en prisión domiciliaria, fue condenado por la Cámara en lo Criminal de Quinta nominación de la ciudad de Córdoba, mediante Sentencia N° 48 de fecha 20/10/1998 por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de encubrimiento, tenencia de arma y munición de guerra en concurso real, coautor de robo calificado reiterado tres hechos, coautor de robo calificado y autor de homicidio calificado en concurso real y autor del delito de robo calificado, todo en concurso real, a la pena de **PRISIÓN PERPETUA, CON DECLARACIÓN DE REINCIDENCIA** y que con fecha 15.08.2024 la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, resolvió mediante sentencia n° 127 : “II) Declarar a E. A. A., filiado supra, autor penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes –primer hecho- y coautor del delito de comercialización de estupefacientes doblemente agravada por ser cometida con la intervención organizada de tres o más personas y en el interior de un lugar de detención -segundo hecho, todo en concurso real y aplicarle la **pena de seis años y seis meses de prisión**, multa de 67,5 unidades fijas, decomiso de los elementos secuestrados y detallados en los considerandos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, declaración de reincidencia y costas ...III) **Unificar** el remanente de la pena impuesta por la Cámara en lo Criminal y Correccional de 5ta. Nominación de la ciudad de Córdoba mediante Sentencia N°48 de fecha 20.10.1998 y la recaída a través de la presente resolución en la **única de prisión perpetua, multa de 67,5 UF, decomiso de los elementos secuestrados y detallados en los considerandos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, declaración de reincidencia y costas** (Art. 58 del C.P.)...”. “(...)” VI) **Ordenar la realización de una pericia médica a los fines de determinar el estado de salud actual del condenado A. y la viabilidad de que el encierro sea efectivo, habiendo evidenciado que la modalidad domiciliaria fue utilizada para profundizar su actividad delictiva relacionada con el flagelo**

de la droga, con el consiguiente enorme perjuicio a la sociedad y a la salud pública que esto trae aparejado....”, y atento a la pericia médica realizada por el Servicio de Medicina Forense con fecha 20.09.2024 y el informe aclaratorio de fecha 13.08.2025 de donde surge que los peritos médicos dictaminan en relación al nombrado “...su permanencia en un establecimiento penitenciario no le impediría recuperarse o tratar adecuadamente su patología ni la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le resultaría inadecuada, por dicha condición médica, ni implicaría un trato indigno, inhumano, cruel o degradante...” y concluyen “...E. A. A. puede permanecer alojado en un establecimiento penitenciario...” y demás constancias de autos; **SE RESUELVE:** Ordenar la detención del penado A., E. A., DNI N° xxx, leg. Penitenciario n° xxx, hijo de A. A. A. y B. M., Fecha Nacimiento: 21/05/1960, nro. prontuario pcial: n°: xxx Secc D.P., el que una vez habido, deberá ser alojado en el Complejo Carcelario n° 1 — Bower, a disposición de este juzgado de ejecución penal n° 1, **a los fines de iniciación del incidente de revocación de la prisión domiciliaria**, prevista en el art. 34 de la ley 24.660. **Que el interno A. se encuentra alojado en el Complejo Carcelario n° 1 desde entonces.-**

IX) Que corrida vista al fiscal sobre el incidente de revocación, el mismo se expide a favor de la revocación mediante dictamen de fecha 26.08.2025 y manifiesta: “...Análisis: Que la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad prevé como alternativa para situaciones especiales- entre otras- la prisión domiciliaria (art. 32 de la ley 24.660): “...El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: **a)** Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario (...).Previo a expedirme, es dable recordar que la concesión de la **prisión domiciliaria es una facultad del órgano judicial y no un imperativo legal (art. 10 CP y 32 Ley 24.660, conforme redacción Ley**

26.472) en consecuencia, considero que la decisión que se adopte debe fundarse en dos pilares básicos: el primero, que el arresto domiciliario asegure debidamente el fin perseguido por la ley y el segundo, que se preserven los objetivos buscados por la ley al establecer el arresto domiciliario, esto es, impedir que la privación de la libertad se muestre especialmente aflictiva y que resulte configurativa de un trato cruel, inhumano y degradante en razón de tornar imposible la recuperación o el tratamiento médico adecuado del interno enfermo en un centro carcelario (art. 32 inc. a Ley 24660). Además “...**la enfermedad no habilita per se el encierro domiciliario**, sino que la ley autoriza esta excepcional modalidad en aquellos casos en que a la afección de la salud se suma un plus, consistente en la obstaculización del adecuado tratamiento e inviabilidad del alojamiento en un establecimiento hospitalario...” (TSJ, Sala Penal, "Rocha", S. n° 311, 24/11/2009; “Juárez”, S. n° 95, 4/8/2010; entre otros). Por otra parte, nuestro máximo Tribunal expresó en reiterados fallos que el arresto domiciliario no configura un derecho subjetivo del interno, sino que se trata de una facultad del órgano jurisdiccional interviniente. En este contexto manifestó que: “La prisión domiciliaria no constituye un cese de la pena impuesta ni su suspensión, sino como claramente surge de su nombre y de su ubicación en la legislación, se trata de una alternativa para situaciones especiales en las que los muros de la cárcel son sustituidos por un encierro en el domicilio fijado bajo el cuidado de otra persona o institución. Resulta en definitiva una atenuada modalidad de ejecución del encierro que implica la pena privativa de libertad (...) La decisión de otorgar la prisión domiciliaria es una facultad discrecional del órgano jurisdiccional. Es que, aún en los casos previstos por la ley, puede limitarse la procedencia del beneficio cuando existan determinadas circunstancias que anulen la falta de necesidad del encerramiento que prima facie se deriva de la comprobación de la hipótesis legal; de lo contrario no se entendería por qué el legislador prefirió el término “podrá” en vez del “deberá”...” (T.S.J., Sala Penal, S. n° 184, 02/07/2013, “LEYES, Plácido Domingo s/ejecución de pena privativa de la libertad -Recurso

de Casación”)....” “(…)” “...Corresponde ahora expedirme sobre el **incidente de revocación de la prisión domiciliaria** por razones de salud, **que fue oportunamente concedida a A.. Precisamente, analizaré si se ha modificado la condición** que dio sustento a la aplicación de dicha modalidad de cumplimiento de la pena conforme al **inc. a)** del art. 32 de la ley 24.660, supuesto que se refiere al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; y por el otro, si corresponde la **revocación** del beneficio por incumplimiento de la condición que le fuera específicamente impuesta “No cometer nuevos delitos, en especial en infracción a la ley 23.737; todo ello bajo apercibimiento de revocársele el beneficio obtenido”. En ambos casos la respuesta es afirmativa. En relación a la causal por la que fue concedido el beneficio de la prisión domiciliaria al penado A., es claro que el mismo ha cesado y así lo expresaron los Dres. Muscarello, Hancevic y Tillard, médicos forenses que examinaron al nombrado el día 13.08.2025 y concluyeron: “...cabe destacar que la patología que padece puede presentar complicaciones independientemente del lugar de alojamiento, por lo que su permanencia en un establecimiento penitenciario no le impediría recuperarse o tratar adecuadamente su patología ni la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le resultaría inadecuada, por dicha condición médica, ni implicaría un trato indigno, inhumano, cruel o degradante. Por todo lo antes citado, E. A. A. puede permanecer alojado en un establecimiento penitenciario. Se sugiere que la toma de su medicación antihipertensiva se realice en el servicio Médico Penitenciario para supervisar el cumplimiento del mismo y que continúe bajo seguimiento estricto del Servicio de Cardiología tratante del Hospital Córdoba y se le practiquen los estudios solicitados por dicho servicio. Se indica además que sea evaluado por Guardia Central del Hospital Córdoba, debido a la hipertensión arterial constatada durante el presente examen”. Por ello, puedo afirmar aquí, que el derecho a la salud del interno se encuentra –a la fecha- plenamente garantizado. Por

otra parte, cabe destacar que el legajo de ejecución acumulado al presente, mediante el cual se ha unificado las condenas de A. se encuentra firme, con lo cual hay certeza en relación al incumplimiento de la condición impuesta en el auto de concesión del beneficio, de prohibición de cometer nuevos delitos, en particular vinculados con infracciones a la ley 23.737, toda vez que el último de los hechos fue cometido encontrándose en prisión domiciliaria. Por todo lo expresado, en opinión de este Representante del Ministerio Público Fiscal **correspondería revocar la prisión domiciliaria oportunamente concedida al interno E. A. A.**, debiendo la autoridad penitenciaria continuar brindando al nombrado asistencia médica integral (art. 143 ley 24.660). Finalmente, se sugiere observar las recomendaciones efectuadas por los Dres. del Servicio de Medicina Forense...”. X) Que con fecha 27.08.2025, se corrió vista a la defensa, el **Dr. Gustavo Taranto, a cargo de la defensa del interno A.**, quien la evacuó con fecha 02.09.2025 y manifestó: “...Gustavo Taranto, en el carácter de defensor del condenado A., E. A., en estos autos: A., E. A. - CPO. DE EJECUCION DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, SAC xxx, ante S.S., respetuosamente comparezco y digo: Que habiéndose resuelto correr vista de esta defensa de la opinión expresada por el Sr. Fiscal, que concluye: “correspondería revocar la prisión domiciliaria oportunamente concedida al interno E. A. A.”.En primer lugar, el Fiscal realiza una serie de consideraciones respecto al pedido de nulidad de la notificación, pero atento que este extremo ya fue resuelto por el Tribunal, no me voy a referiré a esto, teniendo eventualmente otro camino procesal. Insiste el Sr. Fiscal que la modalidad de prisión domiciliaria no es un derecho del penado, sino una facultad del Tribunal, fundado, conforme jurisprudencia del TSJ que en cita del Sr. Fiscal se expresa: “...la enfermedad no habilita per se el encierro domiciliario, sino que la ley autoriza esta excepcional modalidad en aquellos casos en que a la afección de la salud se suma un plus, consistente en la obstaculización del adecuado tratamiento e inviabilidad del alojamiento en un establecimiento hospitalario...” (TSJ, Sala

Penal, "Rocha", S. n° 311, 24/11/2009; "Juárez", S. n° 95, 4/8/2010; entre otros). Así las cosas, no es una facultad discrecional, sino fundada en la posibilidad real y objetiva de que la enfermedad pueda ser tratada y no que por él. Contrario esta se agrave (se sume un plus). No es materia de discusión la existencia de la enfermedad, no solo al momento de concederse la prisión domiciliaria en su primera oportunidad, después de una pericia médica realizada por el profesional que indicó el Tribunal, sino por los ahora profesionales actuantes, por lo que el primer aspecto no está controvertido A. tiene una enfermedad de riesgo. Ahora bien, la posibilidad de tratamiento no está sujeta a un mero informe de pronóstico médico ni a instrucciones dadas por el Tribunal. La posibilidad de A. sea tratado mínimamente, respetando su dignidad y evitando que no se produzca ese plus que señala el TSJ, es constatando si efectivamente se cumple la previsión de los médicos, seguida por el Fiscal. Dice la CN en su artículo 18 impone que "las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo" la historia de este país señala que han sido enfermas y sucias solo explicables como forma de castigo. A. fue alojada después de su detención en una pieza con 3 camas y eran con él 5 personas, le tocaba dormir en el piso (esto fue informado al Tribunal). El domingo 31 de agosto del corriente año A. llamó a su sobrina informándolo que aún no le daban los medicamento y la comida no era la adecuada, agregando que el sábado 30 lo tuvieron que internar con una tensión de 22. En los días que lleva detenido en la cárcel ya se ha violado la obligación de cuidar la salud evitando que se produzca ese plus que señala el TSJ. Ya informamos al Tribunal la falta de atención y el Tribunal ha oficiado al Servicio, desconocemos si se ha obtenido respuesta, si la hay y esta señala una correcta y adecuada atención se está mintiendo. Deberá el Tribunal, previo a tomar una decisión sobre el presente incidente constatar a través de la certificación del médico responsable si se le da a A. la medicación, atención y alimentación adecuada. Asimismo, se informe los efectos que produjeron ya la internación de mi defendido y si esta situación agrava su condición. Sr. Juez la prisión domiciliaria no está basada en un acto discrecional del Tribunal sino en un

*precepto constitucional que supone garantizar a todo ciudadano que la condena será en el marco del respeto al principio constitucional de humanidad, art. 18 C.N. y tratados de derechos humanos incorporados por el Art. 75 inc. 22. Finalmente debo agregar que el Fiscal señala que A. habría violado la obligación de cometer un nuevo delito. Después de ese segundo delito A. fue detenido y la Fiscalía interviniente luego de constatar el agravamiento de la salud de concedió por segunda vez la prisión domiciliaria, por lo que, la que goza actualmente es producto de la segunda vez que se la otorgara y en este segundo período no se ha verificado que haya cometido delito alguno. El Tribunal que condena la última vez, al dar por acreditado ese hecho no ordena que cese la modalidad, sino que se constate que aún existe la condición de salud que lo generó. Esto señalado por el Fiscal, no es un argumento válido. Sr. Juez, a A. le concedieron 2 veces la prisión domiciliaria no como un beneficio discrecional de un Juez, sino como consecuencia de la gravedad de su afección. La enfermedad crónica de A. se incrementó con la internación en la cárcel, se le impone una situación inhumana, por falta de cuidados, medicamentos y atención. Lleva años enfermo y claro en su casa o en la cárcel puede morir igual, pero imponérselo que este desenlace sea bajo encierro y producto de esta modalidad viola el referido principio de humanidad. A pocos días de estar en la cárcel ya ha sido internado, no existe posibilidad alguna que mejore o al menos lleve dignamente su enfermedad con un mínimo de cuidado. La presión alta no tratada adecuadamente mata y aun cuando se afirme que igual moriría adecuadamente tratado, si intencionalmente o menospreciando esta posibilidad se lo expone a un agravamiento o la muerte, se cometerá un delito, responsabilidad exclusiva de quienes allí dispongan esa condición. Así las cosas, solicito que previo a resolver se constate efectivamente **por profesionales responsables** los hechos señalados y denunciados previamente. Finalmente se disponga la continuidad de la prisión domiciliaria. Para la hipótesis de una resolución contraria a la pretensión de esta parte, formula reserva del CASO FEDERAL para ocurrir por vía del recurso extraordinario previsto por el art. 14 de la*

Ley 48 por ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que tal pronunciamiento afectaría derechos de rango constitucional, tales como el del debido proceso, la defensa en juicio, el principio de reserva penal y falta de fundamentación suficiente y principio de humanidad, previstos en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional y la doctrina de la Sentencia arbitraria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ”.

Y CONSIDERANDO:

Que, en orden a las constancias obrantes en autos, y que fueran relacionadas precedentemente, es menester analizar si corresponde que el interno **A., E. A.**, permanezca cumpliendo la pena impuesta bajo la modalidad de prisión domiciliaria o si corresponde su revocación.

1– A tal efecto se debe necesariamente hacer mención que la modalidad de prisión domiciliaria fue otorgada por encontrarse presente al momento de la resolución, afecciones de salud en la persona de A., y cumpliendo dicha modalidad de prisión, es la ocasión y lugar donde cometió hechos delictivos por los que resultó ser finalmente condenado. Así las cosas, la cuestión enunciada precedentemente debe ser respondida fijando como punto de partida si es o no posible la revocación cuando durante la prisión domiciliaria el condenado comete un nuevo delito en ese ámbito, sin que hubiese violado el deber de permanecer en ese domicilio. De igual modo, ante la disminución o desaparición de las dolencias de salud que dieron lugar a la prisión domiciliaria, puede o no dar lugar a dicha revocación.

Para dar respuesta a dichos planteos, resulta de aplicación el precedente de nuestro Excmo. TSJ in re “Gastón” (Sent. N° 54 del 06/3/2019), por cuanto resulta aplicable la ley vigente al momento de cometerse el delito (Art. 2 del C. Penal). Así las cosas, NO resulta aplicable la reforma operada por la Ley 27.375 (Bol. Of. 28/7/2017), y ello es así, aunque posteriores hechos de la condena unificada, fuesen posteriores a dicha reforma (TSJ, “Urán”, sent. 532 del 11/12/2017 y “Aroca Beninatti”, sent. 127 del 08/5/2020). En efecto, no puede de manera

alguna estarse a la ley vigente al *momento en que se otorgó* la prisión domiciliaria o fecha de su otorgamiento, sino a la fecha del *hecho* de condena. El art. 34 vigente al momento de la comisión del hecho de condena rezaba “El juez de ejecución o juez competente revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren”. Por ello, en lo que hace al caso aquí analizado, la desaparición de las causas médicas o de enfermedad que motivaron su otorgamiento no dan lugar a su revocatoria. **2-** Queda por indagar si la comisión de un delito durante la prisión domiciliaria y ocurrido en ese ámbito, da lugar a la revocación de dicha modalidad. Para entrar al asunto, la otra causal establecida por el referido artículo 34 es cuando los *resultados de la supervisión así lo aconsejaren*. A tal efecto, se cuenta en la causa con una condena que da cuenta de la comisión del delito de comercialización de estupefacientes en el ámbito del domicilio donde residía A., lugar donde cumplía la prisión domiciliaria. Este evento no se encuentra expresamente previsto en el artículo 34 por lo que de manera literal no es posible subsumir esta circunstancia en alguna de las hipótesis previstas en dicha norma. Sin embargo, la télesis o fin deseado por la causal indicada permite inferir que las circunstancias pretendidas literalmente, y que permiten la revocación, son por verse en jaque intereses mucho menores que la comisión de un delito, y sin perjuicio de ello, su efecto es la revocatoria. En efecto, la supervisión puede aconsejar la revocatoria cuando las condiciones de vida no son favorables, condiciones edilicias inadecuadas o peligrosas que colocan en peligro la vida o la integridad del alojado, o por otros motivos ponderables (cfr. Laje Anaya, Justo, Notas a la Ley Penitenciaria Nacional, Advocatus, Cba., 1997, pág. 85, nota 247) o que no se consiga cumplir con el propósito por el cual fue otorgado (cfr. Cesano, José Daniel y otros, Ley 24.660 – Ejecución de la pena privativa de la libertad, Alveroni, Cba., 2020, pág. 141), ineptitud de la persona que ejerce la tutoría o el instituto que lo cumple (Cfr. López Axel –Machado Ricardo, Análisis del régimen de ejecución penal, Fabián J. Di Plácido Editor, Bs.

As., 2004, pág. 156), y sobre todo, debe siempre procurarse neutralizar toda posibilidad de fuga (CSJN, 05/11/2020, Fallos 343:1620, recurso de queja, in re “Mulhall”). En definitiva, la causal de la comisión de un delito escapa al análisis doctrinario y hasta jurisprudencial, en orden a que puede concluirse que si causas menos graves conducen a la revocación, es posible inferir que la comisión de un delito en el domicilio donde se cumple la pena privativa de la libertad, no puede inferirse válidamente que si no se salió del domicilio para cometerlo y si no existe ningún informe que desaconseje su continuidad, no se tenga por quebrantada la mínima regla que surge de implícito para transitar por esta modalidad: la buena conducta, entendida ella como normas de buena vecindad, de convivencia dentro de ese ámbito y de la legalidad de sus actos entendido ello como no atentatorias al Código de Faltas o de Convivencia Ciudadana (de carácter contravencional) ni al Código Penal (de carácter delictivo). No puede, en este sentido, tolerarse conductas desaprensivas con el medio ambiente, ni molestias por ruidos o conductas escandalosas que alteren la vecindad, ni mucho menos, delitos mediando violencia de género o familiar, y mucho menos otro tipo de delitos en el domicilio donde habita el condenado.

Dicho ello, la comisión de un delito por parte de quien cumple la prisión domiciliaria en ese ámbito es una causal que justifica por sí misma la revocación de la prisión domiciliaria, siendo imposible conjeturar que si no se halla esa circunstancia prevista en el artículo 34 de la ley 24.660, sirviera esa omisión como amparo para la continuidad de dicha modalidad, conclusión que llevaría al despropósito de poder afirmar que se debería revocar por cuestiones menores y no por violación a intereses mayores. De esta manera, la comisión de un delito en el lugar donde se cumple la prisión domiciliaria faculta como causal grave, a revocarla. Así las cosas, derribada la presunción de inocencia mediante una sentencia dictada en contra de A., por un delito cometido en el lugar o domicilio donde cumpla la prisión domiciliaria, trae como consecuencia inexorable su revocación.

3– Ahora bien, la conclusión precedente obliga a tener en cuenta la causa de su otorgamiento

a los efectos de contener y dar satisfacción a las normas y circunstancias que le dieron lugar. Es que la prisión domiciliaria viene a constituir una de las formas por la que el legislador ha receptado el principio de trato humanitario en la consagración normativa (CN, art. 75 inc. 22; Declaración Americana de los Derechos del Hombre, XXV; Convención Americana sobre los Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica, art. 5, 2; Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos, art. 10; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes, A.G., ONU, 10/12/1984, Considerandos) (TSJ, “Duarte Palo”, sent. 3 del 08/2/2022, entre otros).

Atendiendo a ello, la causal de su otorgamiento obedeció a cuestiones que afectaban la salud de A., pero que mediante las pericias practicadas en durante el presente incidente, dan cuenta de su sensible reducción o desaparición, porque el nombrado *“se encuentra HTA, asintomático y hemodinámicamente estable. Al momento de la presente valoración, se encuentra transitando prisión domiciliaria, situación que no le impide realizar el tratamiento médico, así como asistir a los controles médicos. Esto último se encuentra dificultadoúltimamente, porque según refiere el interno, no consigue turno. Sin embargo, toma la medicación con regularidad y realiza los estudios complementarios según se le han indicado. Salvo complicaciones, la patología que presenta es de carácter crónico, puede cursar con periodos de estabilidad y también puede re-agudizarse e incluso requerir internación en nosocomios, es de destacar que estas complicaciones o reagudizaciones podrían manifestarse ya sea estando privado de la libertad, o en su domicilio. Solicitamos: arbitrar los medios para realizar una consulta médica ambulatoria prontamente con Médico especialista en Cardiología (su médico de cabecera en la Institución Pública en que fue asistido en junio pasado) para control y valoración de su estado de salud actual, así como la realización de todos los estudios complementarios, controles e indicaciones médicas que sean indicados eventualmente por el facultativo en cuestión. Solicitamos, además, se realice una valoración por parte de Médico psiquiatra (sea Perito oficial o médico de Hospital Público) dado lo*

relatado por el interno. En el caso de presentar intercorrientes / descompensaciones agudas, deberá ser asistido por personal médico acorde a la situación presente”.

Oportunamente, se requirió una aclaración sobre las conclusiones periciales, por lo que se dictaminó que “... luego de un minucioso análisis de toda la documental remitida y examen físico del Sr. E. A. A., cabe establecer que padece los antecedentes citados y en relación a su patología de HTA, la misma es de carácter crónico para la cual se encuentra medicado y con controles seriados por servicio de Cardiología del Hospital Córdoba. Si bien la misma, consta ser de difícil manejo, no hay evidencia en la documental remitida de lesión de órgano blanco secundaria a la misma, como ser ACV, infarto de miocardio, daño renal, compromiso vascular aórtico u oftalmológico. Cabe señalar que la principal causa de la falla de respuesta terapéutica al tratamiento anti hipertensivo es la falta de adherencia al mismo por parte del paciente. En este caso, no es posible establecer si el Sr. A. cumple estrictamente o no con el tratamiento indicado. Así mismo, cabe destacar que la patología que padece puede presentar complicaciones independientemente del lugar de alojamiento, por lo que su permanencia en un establecimiento penitenciario no le impediría recuperarse o tratar adecuadamente su patología ni la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le resultaría inadecuada, por dicha condición médica, ni implicaría un trato indigno, inhumano, cruel o degradante. Por todo lo antes citado, E.A. A. puede permanecer alojado en un establecimiento penitenciario. Se sugiere que la toma de su medicación antihipertensiva se realice en el servicio Médico Penitenciario para supervisar el cumplimiento del mismo y que continúe bajo seguimiento estricto del Servicio de Cardiología tratante del Hospital Córdoba y se le practiquen los estudios solicitados por dicho servicio. Se indica además que sea evaluado por Guardia Central del Hospital Córdoba debido a la hipertensión arterial constatada durante el presente examen...”

Así las cosas, como se adelantó, el estado de salud actual de A., permite su alojamiento en

un Establecimiento Penitenciario. Ahora bien, este dictamen es de acuerdo a la ciencia médica, en orden a las posibilidades o recursos que se tienen en un Establecimiento Penitenciario para tratar de mitigar o sanar los síntomas de la enfermedad y salvaguardar la salud, por ello debe realizarse una valoración jurídica en cuanto a si dicho tratamiento, por su modalidad y características, significa un trato inhumano, cruel o degradante, que implique además de un trato indigno, un plus que se agrega a la pena en el sentido aflictivo que se suma a la privación de la libertad. La respuesta deviene negativa por cuanto el tratamiento a la dolencia se efectúa mediante la toma de una medicación de acuerdo a la prescripción médica, y con controles médicos a requerimiento circunstancial, sin que se encuentre comprometida alguna otra modalidad invasiva o impeditiva de actividades comunes en el medio que se trata, que, por supuesto podría incluir abstenerse de esfuerzos o actividades deportivas, como tampoco impone el auxilio de terceros, o medios físicos o mecánicos, y no se visualizan capacidades limitadas respecto a la motricidad o sentidos, todo lo cual, en caso de existir, implicaría la toma de medidas contenedoras en el ámbito carcelario más adecuado (espacios de control reducido, establecimientos hospitalarios o carcelarios de puertas abiertas con tobilleras o control electrónico, etc.).

De esta manera se verifica en el presente la sensible reducción de la circunstancia que dio lugar al otorgamiento de la medida, siendo posible su tratamiento y alojamiento en un Establecimiento Carcelario, y su reinserción en dicho lugar de ningún modo ofende las normas aludidas, porque no significa de modo alguno que ello se traduzca en un trato inhumano, indigno, cruel o degradante a la persona de A. (TSJ, "Derobertis", sent. 264 del 13/5/2025 y "Quiroga", sent. 339, del 02/7/2025; ambas por mayoría);

4- En conclusión, debe revocarse la prisión domiciliaria concedida a A., E. A. y en consecuencia continuar el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia condenatoria, en Establecimiento Penitenciario.

Sin perjuicio de ello, corresponde disponer que la Autoridad Penitenciaria disponga lo

necesario para que el interno **A., E. A., Leg. N° xxx**, sea controlado médicamente, quedando autorizado su traslado a nosocomios del medio libre, con la permanente y debida custodia. **Asimismo, para que, en caso de detectar alguna situación de salud que signifique para el interno la imposibilidad de recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia en el Establecimiento Carcelario donde se aloja, proceda al inmediato traslado e internación, en caso de ser necesario, con noticia urgente a este Juzgado de Ejecución.**

5- HONORARIOS: Corresponde regular honorarios en función de la actividad desplegada a lo largo del trámite incidental en autos por **el defensor, Dr. Gustavo Taranto**, quien actuó en defensa del condenado **A., E. A., leg. N° xxx**, teniendo en cuenta la obligación impuesta por ley 9459 y sus modificatorias de regular honorarios profesionales por su labor profesional en el presente incidente, a la luz de los estándares fijados por los artículos 32 y 39 de dicho cuerpo legal, en la suma equivalente a diez (10) jus, los que serán a cargo de su defendido (arts. 24, 26, 32, 34, 36, 39, 83 y 89, ley 9459 y sus modificatorias).

Por todo ello y normas legales citadas, **SE RESUELVE:**

I) REVOCAR la prisión domiciliaria otorgada oportunamente al interno **A., E. A., Leg. N° xxx**, por haber cometido un delito en dicho ámbito, y en consecuencia disponer que el nombrado cumpla la pena privativa de la libertad en un Establecimiento Penitenciario a cargo del Servicio Penitenciario de Córdoba (art. 34, ley 24.660).

II) DISPONER que la Autoridad Penitenciaria controle médicamente al interno **A., E. A.**, quedando autorizado su traslado a nosocomios del medio libre, con la permanente y debida custodia, en caso de ser necesario, y **en caso de detectar alguna situación de salud que signifique para el interno la imposibilidad de recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia en el lugar donde se aloja, proceda al inmediato traslado e internación a un Nosocomio del medio libre en caso de ser necesario, con noticia urgente**

a este Juzgado de Ejecución.

III) REGULAR honorarios en función de la actividad desplegada a lo largo del trámite incidental en autos por el defensor, Dr. Gustavo Taranto, teniendo en cuenta la obligación impuesta por ley 9459 y sus modificatorias de regular honorarios profesionales por su labor profesional en el presente incidente, a la luz de los estándares fijados por los artículos 32 y 39 de dicho cuerpo legal, en la suma equivalente a diez (10) jus, los que serán a cargo de su defendido (arts. 24, 26, 32, 34, 36, 39, 83 y 89, ley 9459 y sus modificatorias).

PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y COMUNÍQUESE.-

Texto Firmado digitalmente por:

LAJE ROS Cristobal

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.09.05

BIZZARRI Jose Luis

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.09.05